



Д-р Йохан Зельцер
Специалист по диагностической и интервенционной радиологии
№ лицензии 130889
№ лицензии специалиста 33492

MPT таза

Имя: Жерлицина Анастасия **Уд. л:** ME9239960 **Дата рождения:** 25-го апреля 1976

Исследование проведено 24-го августа 2023, расшифровка выполнена 31-го мая 2023.

Показания к исследованию:

Обследование в рамках желудочно-кишечной стромальной опухоли, с целью исключения саркомы.

Описание наблюдений:

Выполнено сравнение с предыдущим КТ-исследованием от 23-го августа 2022.

Живот:

Сигнал от печени в пределах нормы. Наблюдается дисморфия и гипертрофия левой доли печени.

Наблюдаются патологические очаги в печени:

- Образование с распространением в сегменты 5 и 6, размером около 16,5 на 10,8 см, оказывающее давление на структуры ворот печени.
- Образование диаметром 10 на 21 мм в сегменте 8 (расположено спереди и кверху в сравнении с вышеописанным образованием).
- Образование диаметром 57 на 82 мм в 7 и 8 сегментах.
- Образование диаметром 45 на 66 в левой доле, приводящее к умеренному расширению внутрипеченочных желчных путей сверху.

От всех вышеописанных очагов исходит неоднородный сигнал с некротическим и геморрагическим компонентом и поэтапным контрастированием. Без признаков обызвествлений на КТ.

Следует отметить побочное кистозное образование диаметром 6 мм, позади основного процесса в правой доле, в 6-м сегменте сзади.

Амплитуда печени измеряется на 20,7 см по среднеключичной линии.

Небольшое количество жидкости вокруг печени и селезенки.

Воротная вена и печеночные вены открыты, без тромбозов.

В малой кривизне желудка, в стенке, наблюдается объемный процесс размером около 48 на 55 мм, с теми же характеристиками, что и образования в печени.

Желчный пузырь сдавлен и сдвинут вниз и влево, без ярковыраженных камней.

Без признаков патологического расширения внепеченочных желчных протоков.

Вирсунгов проток не расширен, в поджелудочной железе нет патологических изменений.

Без признаков патологических изменений в селезенке или почках.

Наблюдется умеренное диффузное утолщение левого надпочечника без узла. Правый надпочечник в норме.

Амплитуда селезенки – 8,7 см.

Без признаков увеличенных забрюшинных или брыжеечных лимфатических узлов в сканируемой области.

Область таза:

Матка кпереди, без отклонения.

Размеры: длина 79 мм, ширина 50 мм, толщина 45 мм.

Толщина эндометрия: 1 мм, в пределах нормы.

Без признаков утолщения переходной зоны и микрокистозных изменений.

В миометрии наблюдается миома в правых стенах (FIGO 5) диаметром около 28 мм,

Наблюдается объемный процесс на ножке на дне матки, размерами около 6 x 9 см.

Образование показывает повышенный сигнал T2 с диффузией высокой степени, без ограничений при аномальной диффузии, соответствует гиперцеллюлярной лейомиоме на ножке (FIGO 7). Внутри лейомиомы на КТ наблюдались обызвествления.

Кистозный процесс диаметром 65 на 57 мм в кисте справа, с «затенением», в связи с эндометриомой. Левый яичник в норме, без кист и эндометриом.

Утолщение тканей в маточном валике, судя по всему, есть спайки с верхним отделом прямой кишки.

Наблюдается утолщение тканей внутри маточно-крестцовых связок.

Утолщение в проксимальном отделе круглых связок, более выраженное справа.

Пузырно-влагалищная и ректовагинальная перегородки выглядят нормально.

Нет признаков гидросальпинкса или гематосальпинкса.

В кармане Дугласа без признаков жидкости или патологических изменений.

Наблюдается предбрюшинная жидкость в небольшом количестве впереди и слева от мочевого пузыря.

Без признаков лимфаденопатии в малом тазу.

Без признаков патологических изменений в мочевом пузыре (при наполненности) или в брюшной стенке.

Заключение:

- 1. Изображение в первую очередь соответствует желудочно-кишечной стромальной опухоли стенки желудка с вторичными поражениями в двух долях печени (поражения некротического характера, с геморрагическими изменениями без обызвествлений и без признаков лимфаденопатии).**
- 2. Миома на ножке соответствует гиперклеточной лейомиоме дна матки: при отсутствии ограничения при аномальной диффузии, диагноз саркома маловероятен.**
- 3. Эндометриома правого яичника с глубокими очагами эндометриоза (в валике и, возможно, в круглых связках).**
- 4. Перитонеальная жидкость в небольшом количестве в брюшной полости и малом тазу без явных признаков вторичного перитонеального распространения.**

Д-р Зельцер Йоханн